

TEMA 50



LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS ADICCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La atención social a las adicciones en el Ayuntamiento de Madrid.	
1.1.- Red de atención integral a las adicciones de la Ciudad de Madrid. 1.2.- Centros y Servicios del Instituto de Adicciones. 1.3.- Descripción de los servicios y recursos de apoyo al tratamiento integral.	
2.- Protocolo de intervención desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Adicciones de Madrid Salud.	
2.1.- El/la trabajador/a social en el proceso de atención integral. 2.2.- Intervenciones con colectivos con necesidades especiales. 2.3.- Intervenciones con la comunidad. 2.4.- Intervención grupal en los CAD.	

0.- INTRODUCCIÓN.

En estos 20 años el camino recorrido en drogodependencias ha sido rico y complejo, teniéndose que superar múltiples dificultades: el rechazo inicial a los programas ambulatorios, la oposición vecinal a la apertura de centros de atención a drogodependientes o a la implementación de programas de metadona.

Primeras actuaciones municipales en materia de drogodependencias.

Las primeras respuestas a la pandemia de la **heroína** se producen a finales de los 70 con la creación de unidades de apoyo a heroinodependientes y sus familias para apoyar la financiación del tratamiento en las primeras comunidades terapéuticas. Un pequeño grupo de profesionales de Salud Mental realizo seguimientos de las familias de los afectados.

En enero de 1.987 se pone en marcha el primer **Centro Municipal de Atención a las Drogodependencias (CAD)** en el Puente de Vallecas.

Creación de la Comisión Antidroga.

El 31 de julio de 1.987 el Ayuntamiento de Madrid crea la Comisión Antidroga, integrada por todos los grupos políticos con representación municipal. Su finalidad era realizar un diagnóstico de la situación de las drogodependencias en Madrid y la formulación de las medidas necesarias. En 1.992 se incorporaron los representantes de las principales ONGs que trabajaban en este ámbito: Cáritas Madrid, Cruz Roja, FERMAD, UNAD, Proyecto Hombre ...

Aprobación del Plan Municipal contra las Drogas y primeras actuaciones (1.988-1.990).

El 6 de mayo de 1.988 se aprobó el Plan Municipal contra las Drogas, quedando adscrita su gestión a la entonces Concejalía de Salud y Servicios Sociales.

Los objetivos del PMD eran diseñar y desarrollar **programas de prevención**, crear una red amplia y diversificada de **recursos de asistencia y reinserción social**, impulsar la **participación social y colaboración de las asociaciones** ... y como líneas prioritarias se planteaba el desarrollo de programas de **colaboración con Instituciones Penitenciarias y la Administración de Justicia** o la creación de mecanismos de coordinación o colaboración con la iniciativa social.

Quinquenio 1.991-1.995: etapa de crecimiento y diversificación en diferentes ámbitos y primera reflexión sobre el modelo de atención.

La Red Municipal se enriquece con nuevos dispositivos y programas: Comunidad Terapéutica de Barajas, plazas en pisos de apoyo a la reinserción, talleres de inserción laboral, servicios específicos de reducción de daños (Centro de Contacto y Atención Sociosanitaria) ...

En octubre de 1.995 se realiza la primera **Revisión del Modelo de Atención a las Drogodependencias**, incorporándose programas dirigidos a colectivos específicos como drogodependientes sin hogar, alcohólicos ...

En el ámbito de la **prevención** se ponen en marcha nuevas iniciativas: Servicio de Apoyo a la Prevención, Programa de Prevención del Alcoholismo Juvenil, Programa de Intervención con Menores, Escuela Municipal de Formación Familiar y del Voluntariado en Drogodependencias ...

Quinquenio 1.996-2.000: implementación y crecimiento de los programas de sustitutivos opiáceos.

En julio de 1.997 se firma un Convenio Tripartito entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española que permite la rápida puesta en marcha de programas de sustitutivos opiáceos, en dos años se dota a la red de 3.000 plazas en programas de mantenimiento con metadona. En años siguientes se firmaron otros convenios de colaboración con entidades como Cáritas Madrid o Proyecto Hombre. La implementación de estos programas se realiza en medio de una importante polémica en torno a los mismos.

La capacidad de estos programas para captar y retener en la red a un amplio colectivo de drogodependientes contribuirá a la progresiva disminución de la alarma social respecto al problema de las drogas.

Trienio 2.001-2.003: consolidación de los nuevos Centros y diversificación de programas.

En esta etapa se va a consolidar la red, contando ésta con 7 CADs y 5 Centros Específicos para programas de mantenimiento con metadona.

De forma paralela se va a diversificar la oferta de programas libres de drogas, en función de las necesidades y perfiles de la demanda. Es importante el paulatino crecimiento del porcentaje de casos tratados por adicción al alcohol, a cocaína y otros estimulantes o al cannabis.

La atención desarrollada en el marco de la **educación para la salud** permite la mejora de importantes indicadores: menor utilización de la vía intravenosa, descenso porcentual del VIH o disminución de la prevalencia de la tuberculosis y la hepatitis.

En el ámbito de la **prevención** se pone en marcha el Servicio Telefónico de Información Familiar, el programa de reducción de daños relacionados con el alcohol "No –t pases entera –t" ...

Cuatrienio 2.004-2.007: etapa de expansión y crecimiento de la red. Creación del Instituto de Adicciones.

En el 2.003 el PMD pasa a depender del **Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad,** junto con la red de Centros Municipales de Salud, iniciándose un proceso que culminará con la creación del **Organismo Autónomo "Madrid Salud"** (el 18 de noviembre de 2.004), cuya finalidad será la gestión de las políticas municipales en materia de Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

La actual estructura administrativa integra el **Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid**, del que dependen todas las actuaciones en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos.

1.- LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS ADICCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El **Organismo Autónomo Madrid Salud** tiene como finalidad la **gestión de las políticas municipales en materia de Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos**, dentro del término municipal de Madrid. La **Subdirección General de Adicciones** desarrolla estas competencias a través de tres Departamentos: **Departamento de Prevención, Departamento de Asistencia y Departamento de Reinserción.**

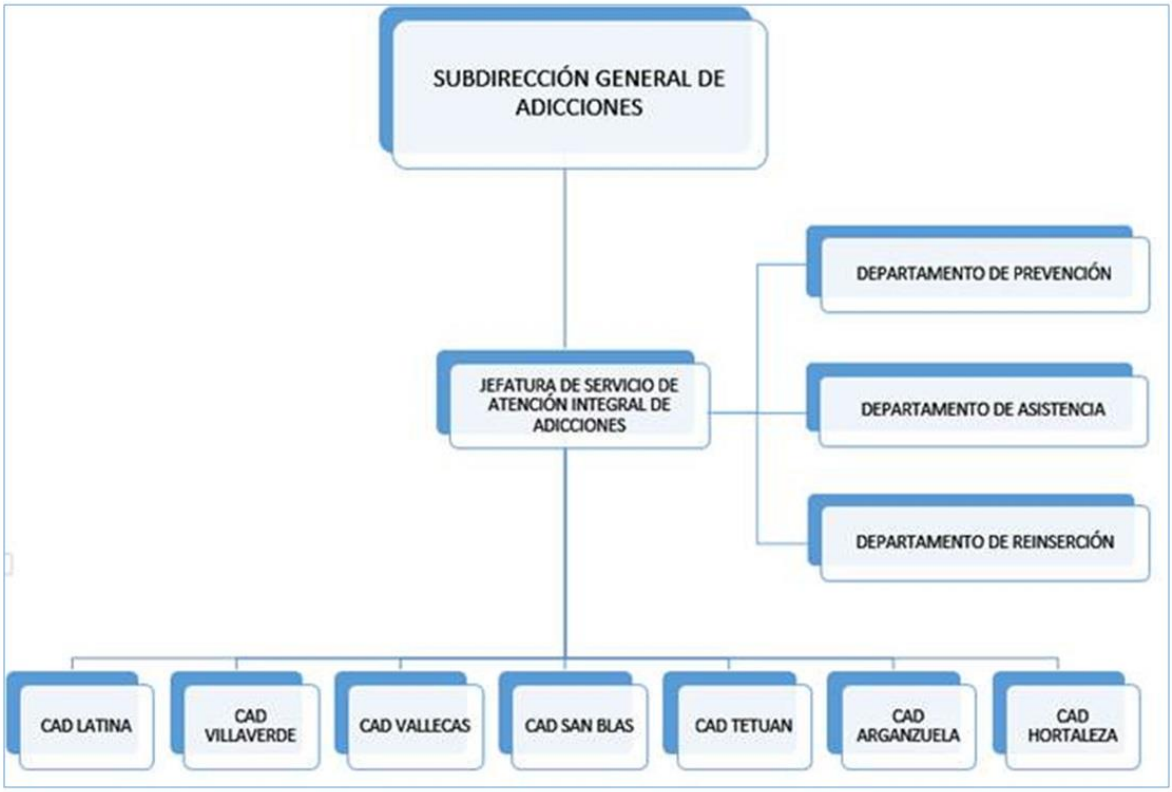
De esta Jefatura dependen los 10 **(Centros de Atención a las Adicciones)** CADs:

- **7 CAD**: Latina, Villaverde, Vallecas, San Blas, Tetuán, Arganzuela y Hortaleza.
- **3 CCAD** (Centros Concertados de Atención a las Adicciones): Casa de Campo (Cruz Roja), Cáritas (Santa Hortensia) y Centro (Cruz Roja).

La coordinación interna del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid se realiza en torno a **espacios de trabajo permanentes** entre las distintas unidades y niveles de la Organización:

- Espacios de coordinación Subdirección - Servicios - Departamentos.
- Espacios Interdepartamentales.
- Espacios de coordinación entre los diferentes "Servicios Centrales" (Subdirección, Servicios, Departamentos) y los Centros de Atención a las Adicciones (CAD y CCCAD).
- Espacios de coordinación Inter-CAD.
- Espacios de coordinación entre los diferentes niveles de la organización y las entidades externas, que gestionan los programas y servicios que forman parte de la Red del Instituto de Adicciones.

Además de los espacios de coordinación permanentes y reglados, existe la posibilidad de articular **grupos de trabajo**, formados por profesionales pertenecientes a los diversos niveles de la organización, para el desarrollo de tareas sobre temas concretos, más o menos puntuales: desarrollo de acciones de mejora dentro del Plan de Calidad del Instituto, diseño de programas o de protocolos de actuación, preparación de documentación técnica, desarrollo de ponencias o de tareas docentes, investigaciones, publicaciones, etc.



1.1.- RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID.

La propia complejidad del fenómeno de las adicciones y la necesidad de realizar un abordaje integral del mismo ha planteado la necesidad de **generar recursos en red**, de modo que sea posible dar respuesta a los diferentes problemas asociados a las mismas, que afectan a diversas vertientes de la vida de la ciudadanía.

Cada recurso o servicio que forma parte de la red no es, por sí solo, una solución al problema, sino un elemento más de un proceso de intervención complejo, del que forma parte.

Para poder articular una respuesta en red, que sea integral y coherente con la diversidad de problemáticas relacionadas con las adicciones, es necesario contar con una amplia variedad de servicios y recursos, coordinados entre sí de forma ordenada. La ordenación de estos recursos, para ser eficaz, debe articularse basándose en unos niveles de acción a partir de una asignación y diversificación de funciones que resulten complementarias.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el objetivo último de todo proceso de intervención en adicciones es lograr que las personas afectadas sean capaces de desarrollar un estilo de vida que posibilite su participación activa en la vida social y la incorporación de hábitos saludables en todos los ámbitos de su vida sin necesidad de recurrir al consumo de drogas, resulta necesario lograr una estrecha relación y coordinación entre la Red de Atención a las Drogodependencias y otras redes sociales y servicios: Atención Primaria de Salud, Salud Mental, Servicios Sociales, Sistema Educativo, mundo empresarial, tejido asociativo y la Sociedad Civil en general, potenciando las sinergias necesarias para favorecer los procesos de normalización e integración social de las personas afectadas por un problema de adicciones.

La **Ley 5/2002, de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid** define, en su **artículo 20**, el Sistema de Asistencia al Drogodependiente como una "**red de atención pública y diversificada**", que integra de forma coordinada centros y servicios generales y específicos, complementados con recursos privados debidamente acreditados.

Por otra parte, esta misma Ley, en su **artículo 22**, resalta la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a los recursos, actividades y prestaciones del sistema, insertándolas en el conjunto de las acciones normalizadas en todos los servicios públicos.

Desde el Instituto de Adicciones se plantea la ordenación de los recursos que forman parte de la Red de Tratamiento Integral a las Adicciones en los siguientes niveles:

1.1.1.- PRIMER NIVEL O NIVEL DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD.

En este nivel se incluyen servicios cuyo objetivo principal es la **detección y captación de personas con adicciones que no acceden a los centros de tratamiento ambulatorio**, proporcionando orientación, información y una atención social y/o sanitaria básicas a dichas personas.

Los objetivos de las diferentes intervenciones, aunque no de forma exclusiva, se realizan desde la **perspectiva de la reducción de daños**. La atención se produce en un contexto próximo a las personas, que no pueden o no quieren dejar de consumir, con el fin de acercar la red a este colectivo que no suele acceder a los centros normalizados.

Una función importante de este tipo de recursos es la de motivar para el tratamiento y favorecer el establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado que mejore la adherencia y facilite la derivación a recursos de segundo nivel, cuando ello se considere necesario.

Los servicios y programas que forman parte de este nivel son los siguientes:

- **Centro de Atención Básica Sociosanitaria (nocturno).**
- **Unidad Móvil de Reducción del Daño Madroño.**
- **Programa de Intervención en Drogodependencias con Población Inmigrante Istmo.**
- **Programa de Mediación Comunitaria.**

1.1.2.- SEGUNDO NIVEL. CENTROS AMBULATORIOS: CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y CENTROS CONCERTADOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES: CAD Y CCAD.

Los CAD y CCAD son **centros de carácter socio-sanitario** que están dotados de una amplia plantilla de profesionales, pertenecientes a diferentes disciplinas (medicina, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y enfermería, técnicos/as de laboratorio, auxiliares de enfermería, personal administrativo y de servicios, etc.).

Forman parte de la red del Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid). Desde sus equipos e instalaciones se presta una atención personalizada individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a aquellas personas que presentan riesgo o trastornos relacionados con el consumo de sustancias u otras adicciones

- Actúan como el **eje de la intervención integral** las personas en tratamiento y son los centros de referencia de la red, coordinando las actuaciones de los diferentes servicios que intervienen en el proceso terapéutico.
- En ellos se diseña y se coordina el **plan de intervención individualizada** con cada paciente, tal y como se describe más adelante.
- Desde estos centros **se deriva a las y los pacientes a recursos o dispositivos de tercer nivel** cuando precisan de una atención con un mayor grado de especificidad que no puede ser prestada en los CAD y CCAD. Estas derivaciones pueden ser temporales, durante el período de tiempo necesario para que se consigan unos determinados objetivos (un ejemplo sería la derivación temporal a una Comunidad Terapéutica o a una Unidad de Desintoxicación Hospitalaria), o bien pueden ser derivaciones parciales, durante las cuales se trabaja simultáneamente desde el CAD o CCAD y desde el dispositivo de tercer nivel (un ejemplo sería la derivación a un Servicio de Orientación Laboral o a un recurso convivencial terapéutico).
- Paralelamente, los recursos de segundo nivel mantienen también una estrecha coordinación con los recursos de primer nivel para favorecer los objetivos de normalización e integración social. Es necesario, por lo tanto, mantener una coordinación permanente y fluida entre niveles.

1.1.3.- TERCER NIVEL. RECURSOS DE MAYOR NIVEL DE ESPECIFICIDAD.

En este nivel se agrupan **recursos con un mayor grado de especificidad**, a los que se accede por derivación desde los CAD y CCAD, para la consecución de unos objetivos concretos en una o en varias de las áreas de intervención con las personas en tratamiento.

- Prestan una **atención en áreas específicas, durante un tiempo limitado**, que no puede ser ofertada desde los recursos de segundo nivel.
- Mantienen una coordinación permanente con los Centros de Atención a las Adicciones para facilitar la consecución de objetivos terapéuticos.
- Derivan de nuevo a los pacientes a los centros de referencia una vez finalizada su intervención.

En este nivel se sitúan servicios como los siguientes: **Unidades de desintoxicación hospitalaria (UDH), Centro de Patología dual comunidades terapéuticas (CT), Recursos convivenciales de apoyo al tratamiento o a la reinserción, Servicios de Orientación Laboral, Talleres, SAJIAD**, etc.

1.2.- CENTROS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

El Instituto de Adicciones cuenta en la actualidad con una **amplia Red de centros, servicios y recursos de apoyo a la prevención, al tratamiento y a la reinserción en drogodependencias**, ya sean éstos de gestión propia o bien de gestión indirecta, a través de contratos o convenios con distintas empresas, entidades y organizaciones no gubernamentales.

Se detallan a continuación los centros y servicios que forman parte de la Red, tal como están recogidos en el Catálogo de Centros y Servicios de Madrid Salud.

1.2.1.- CENTROS.

Centros de Atención a las Adicciones (CAD y CCAD).	**10 centros ambulatorios**: 7 CAD y 3 centros concertados de atención a las Adicciones (CCAD). Desde sus equipos e instalaciones se presta una atención personalizada individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a aquellas personas que presentan riesgo o trastornos relacionados con el consumo de sustancias u otras adicciones.
Centro de Atención Básica Sociosanitaria.	Es un Programa Municipal Nocturno de Detección y Atención Básica en Proximidad. Centro abierto de 21:00 a 8:00 horas, todos los días de la semana los 365 días del año, con objeto de acercar a la Red Municipal de Atención a las Adicciones el colectivo de población consumidora especialmente vulnerable. Informa, propicia y apoya el ingreso de los afectados en los dispositivos asistenciales. Además. ofrece alimentación básica, reducción de daños y riesgos (educación sanitaria: uso correcto del preservativo, manejo de situaciones de riesgo vital, higiene, alimentación ...), vacunaciones para enfermedades infectocontagiosas, intervenciones sanitarias básicas, acompañamiento, etc. Tiene una capacidad máxima para 60 personas diarias. Las actuaciones de acompañamiento se realizan en horario de mañana o de tarde. Para el logro de sus objetivos de coordina con las redes asistenciales de carácter social y sanitario: SAMUR Social, centros de salud, casas de acogida, comedores públicos, roperos, albergues, centros de servicios sociales y el resto de dispositivos de la red asistencial del Instituto de Adicciones.

1.2.2.- SERVICIOS.

Recursos de Apoyo al Tratamiento y a la Reinserción.	Comunidades terapéuticas. Pisos de apoyo al tratamiento y reinserción. Unidad Hospitalaria de Desintoxicación de Alcohol, Centro de Patología Dual. Centros de día, Servicio de Orientación Laboral. Talleres de capacitación laboral y empleo; Servicio de Asesoramiento a Jueces e información al detenido drogodependiente (SAJIAD); otros recursos de apoyo a la Integración Social: Tratamiento odontológico, Servicio de mediación comunitaria, etc.
Servicio de Prevención de Adicciones para Familias.	Servicio de Prevención atendido por profesionales expertos/expertas en adicciones y en intervención familiar. Ofrece orientación on-line, telefónica y presencial sobre este problema.
Unidad Móvil de Reducción del Daño "Madroño".	Es un dispositivo móvil para personas drogodependientes que no han acudido a la red de centros asistenciales. Tiene capacidad para realizar una intervención sociosanitaria básica en el interior del vehículo y en medio abierto. Permite atender en proximidad, vincular e informar, y facilita suplementos nutricionales básicos. Se coordina con los dispositivos y recursos de la Red Municipal de Atención a Adicciones y con otras redes y entidades relacionadas.
Programa ISTMO de atención a población inmigrante.	Equipo especializado que facilita a la población inmigrante con problemas de abuso de alcohol y otras drogas, el acceso y la buena utilización de los programas y servicios ofertados desde la Red Municipal de Atención a las Adicciones, realizando un seguimiento a lo largo de todo el proceso de intervención.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL.

A continuación, se describen los servicios y recursos que forman parte de la red de Atención Integral a las Adicciones de la Ciudad de Madrid y que tienen como objetivo común **apoyar en distintos momentos del proceso de captación proactiva, de asistencia y de integración social de los pacientes, tanto si son adolescentes y jóvenes como si son mayores de 24 años.** Se describen los servicios y recursos de primer y de tercer nivel, habida cuenta que los CAD y los CCAD ocuparían el segundo, si bien como en otras ocasiones, los límites entre distintos niveles han de ser interpretados con flexibilidad.

El acceso a los recursos del tercer nivel, se realiza siempre, a través de derivación desde los centros ambulatorios, con el propósito de conseguir determinados objetivos en las diversas áreas de atención, si bien en algunos casos las acciones a realizar en algunos de estos servicios se inician en los propios Centros de Atención a las Adicciones y se continúan y completan en estos recursos de apoyo. Se trata pues, en su mayoría, de recursos externos al nivel de atención ambulatoria.

1.3.1.- DISPOSITIVOS DE PRIMER NIVEL.

Unidad Móvil Municipal de Reducción del Daño "Madroño".

Dispositivo móvil para personas drogodependientes que no quieren o no pueden acudir a la red de centros asistenciales. Realiza intervención sociosanitaria tanto en el propio vehículo como en la calle.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Ofrecer a las personas drogodependientes, que se encuentran en especial situación de exclusión social, una atención básica que prevenga el desarrollo de enfermedades asociadas a la drogodependencia y reduzca los daños y riesgos de la conducta adictiva, facilitando al mismo tiempo su captación y derivación a otros servicios.	▪ Detectar personas drogodependientes en situación de exclusión social. ▪ Captar a las personas con dificultades de acceso a la red y facilitar su incorporación a los diferentes programas y servicios. ▪ Informar sobre programas y recursos de atención integral a las adicciones. ▪ Motivar para el tratamiento. ▪ Prestar una atención sanitaria básica. ▪ Reducir los daños y riesgos asociados a las drogodependencias. ▪ Prestar servicios básicos: - de alimentación - de ropa - de higiene ▪ Facilitar el acceso a otras prestaciones y recursos públicos y comunitarios.	▪ Dispensación de metadona. ▪ Atención sanitaria básica. ▪ Información y control de VIH/SIDA, hepatitis, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. ▪ Educación para la salud (estrategias de reducción del consumo, consumo de menor riesgo, etc.). ▪ Información y asesoramiento sobre recursos sociales. ▪ Acompañamiento a recursos y apoyo durante el tratamiento. ▪ Intercambio de jeringuillas y distribución de preservativos, papel de aluminio, etc. ▪ Prestaciones en alimentación y vestuario. ▪ Atención psiquiátrica de bajo umbral.

Centro de Atención Básica Sociosanitaria para Drogodependientes (CAB).

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Extender la asistencia y una atención socio-sanitaria básica a la población adicta que se encuentra alejada de los recursos normalizados y reducir los daños asociados a las adicciones.	▪ Acercar la red integral de atención a las adicciones al colectivo de población consumidora de la Ciudad de Madrid, ofreciéndoles los distintos programas de intervención adaptados a sus especiales características.	▪ Servicio de alimentación básica ▪ Intercambio personalizado de jeringuillas y distribución de material de consumo estéril (papel de aluminio, etc.). ▪ Educación sanitaria individualizada orientada a la reducción de daños y riesgos.

	▪ Prevenir y paliar una serie de consecuencias negativas que frecuentemente aparecen asociadas al consumo de drogas. ▪ Proporcionar información, orientación y material gráfico de apoyo, acerca de los recursos de la red asistencial y en relación al consumo de drogas. ▪ Propiciar y apoyar el ingreso de los afectados en los dispositivos asistenciales. ▪ Mejorar la utilización que los pacientes hacen de los mismos.	▪ Vacunación. ▪ Detección precoz de patologías orgánicas asociadas al consumo. ▪ Cuidados sanitarios básicos. ▪ Información sobre recursos. ▪ Acompañamientos y apoyo en gestiones de tipo socio-sanitario y trámites administrativos. ▪ Gestión de accesos a los Centros de Atención a las Adicciones.

Servicio de intervención en drogodependencias con la población inmigrante en la ciudad de Madrid.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Acercar a la red de atención a las adicciones al colectivo de población inmigrante de la Ciudad de Madrid, ofertándoles los distintos servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social con los que cuentan los centros de la red y realizando tareas de mediación entre este colectivo y los Centros de Atención a las Adicciones, de modo que se facilite la adaptación de la oferta terapéutica a las especiales características y necesidades de esta población.	▪ Conocer la situación de las personas inmigrante con problemas de adicciones en la Ciudad de Madrid, sus características y necesidades. ▪ Mejorar la captación de este colectivo estableciendo vías de acceso cercanas a los mismos. ▪ Ofrecer tratamientos adecuados a las necesidades de esta población. ▪ Interactuar con los recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción para que cubran las necesidades de este colectivo. ▪ Hacer propuestas acerca de nuevos recursos o servicios que resulten necesarios.	▪ Información y orientación sobre los recursos existentes, tanto a la población inmigrante como a los centros y asociaciones que trabajan con esta población. ▪ Asesoramiento y motivación para iniciar tratamiento o contactar con los servicios sociosanitarios de reducción del daño. ▪ Acompañamiento individualizado y seguimiento de los casos a lo largo de todo el proceso de intervención. ▪ Información y ayuda en la tramitación de documentos. ▪ Apoyo lingüístico y de servicios de traducción. ▪ Mediación entre la Red de Atención a las Adicciones y otros servicios de atención a inmigrantes. ▪ Asesoramiento y apoyo a los profesionales de la Red de Atención respecto de las características y necesidades de este colectivo. ▪ Mediación socio lingüística en todas las fases del proceso terapéutico.

Programa de Mediación Comunitaria.

Promueve la mejora de la convivencia en zonas de la ciudad donde existe un conflicto entre vecinos y comerciantes con grupos de personas con problemas de adicción que frecuentan dichas zonas. Se dirige a población adicta que se reúne habitualmente en espacios públicos generando situaciones de tensión y conflicto, y a vecinos, comerciantes y ciudadanos afectados.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Disminuir la conflictividad que en ocasiones provoca la apertura de centros dirigidos a población drogodependiente y/o la presencia de drogodependientes reunidos en zonas determinadas de la ciudad, disminuir las actitudes de rechazo y favorecer la integración social de estas personas.	▪ Conocer las necesidades que los dispositivos de atención a las adicciones de la red municipal presenten en materia de integración socio-comunitaria en su entorno. ▪ Brindar un servicio de mediación comunitaria en aquellas zonas donde se detecten focos de conflictividad en el entorno de los dispositivos de atención. ▪ Reducir el número de drogodependientes que permanecen de forma prolongada en el entorno de los dispositivos de atención o en lugares significativos de uso público, suscitando el descontento vecinal. ▪ Lograr el acceso y una mejor participación de usuarios/as en el proceso de tratamiento y en las actividades programadas desde los centros de atención.	▪ Actúa con presencia directa en las zonas en que se demanda su intervención estudiando las circunstancias que se producen y proponiendo medidas que favorezcan la convivencia sin conflicto. ▪ Contacto fluido con el tejido asociativo de las zonas de posible conflicto y actuaciones de mediación cuando resulta necesario. ▪ Educación de calle en zonas seleccionadas. ▪ Intervenciones individuales con usuarios/as, acompañamientos, etc. ▪ Coordinación con todos los dispositivos de atención de la red, así como con otros servicios y recursos comunitarios (sanitarios, de servicios sociales, etc.). ▪ Programación de actividades en función de las necesidades detectadas en la población atendida, en coordinación con los Centros de Atención a las Adicciones o con otros recursos comunitarios. ▪ Fortalece el tejido asociativo y la dinamización sociocomunitaria impulsando actividades conjuntas. ▪ Promueve el uso adecuado de los espacios públicos. ▪ Motiva a la población adicta hacia un cambio que mejore su salud y estilo de vida facilitando su acceso a la red de atención del Instituto de Adicciones.

1.3.2.- DISPOSITIVOS DE TERCER NIVEL.

Unidad Hospitalaria de desintoxicación de alcohol.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Desintoxicación hospitalaria y estabilización de pacientes con dependencia alcohólica.	▪ Desintoxicación de la dependencia alcohólica. ▪ Estabilización del paciente: atención individual, psicológica y psiquiátrica durante todo el proceso, psicoterapia grupal. ▪ Mejorar la capacidad de autocontrol. ▪ Promover la adquisición de hábitos saludables y pautas de autocuidados. ▪ Favorecer la motivación para la continuidad del tratamiento de modo ambulatorio. ▪ Facilitar el desarrollo de pautas adecuadas de relación. ▪ Promover la ocupación racional del tiempo libre.	▪ Hospitalización de pacientes para la desintoxicación de la dependencia alcohólica (tiempo de estancia aproximada de 14 días). ▪ Abordaje terapéutico integral. ▪ Dispensación de metadona o de otros fármacos según indicación.

Unidad Hospitalaria de desintoxicación de alcohol.

Pacientes con dependencia alcohólica que requieren desintoxicación hospitalaria.

¿Qué servicios ofrece?

- **Desintoxicación** de alcohol
- **Estabilización** del paciente: Atención individual, psicológica y psiquiátrica durante todo el proceso, psicoterapia grupal, educación para la salud, técnicas de autocontrol de ansiedad…

¿Qué horario tiene?

Ingreso en dispositivo hospitalario.

Tiempo de estancia 14 días

Forma de acceso

Se accede exclusivamente a través de los centros de atención a las Adicciones (CAD y CCAD), mediante derivación expresa realizada por indicación del equipo terapéutico.

Centros de Día.

Objetivo general.	Objetivos específicos.	Servicios que presta.
Proporcionar a la población adicta que presenta un importante deterioro socio-sanitario, un espacio donde cubrir las necesidades básicas de relación, alimentación, abrigo, higiene y crear expectativas de mejora de la situación personal.	▪ Proporcionar a esta población un espacio cálido y cómodo donde poder descansar. ▪ Proporcionar servicios de alimentación (almuerzo y comida). ▪ Fomentar la toma de conciencia sobre las diferentes problemáticas individuales y generar dinámicas de cambio a través de la ocupación del tiempo libre y desarrollo de actividades. ▪ Promover espacios y tiempos de socialización que eviten un progresivo aislamiento social, a través de la realización de actividades normalizadas (lectura de prensa, visionado de telediarios y otros programas de televisión, etc.). ▪ Mejorar los hábitos de higiene y autocuidados.	▪ Socio-sanitarios: - Comedor - Duchas - Lavandería - Ropero ▪ Formativos, educativos y de ocio: - Talleres de Manualidades - Taller de Ofimática - Vídeo - fórum - Salidas y Excursiones - Conferencias

Hay dos Centros de Día, el de Casa de Campo (atiende a personas con adicciones que se encuentran en situación de calle, en centros de acogida o en situación inestable y precisan un espacio alternativo a la calle) y el de Cáritas (recurso orientado a la estabilización en el tratamiento para personas con adicciones que, por sus carencias sociofamiliares u otras, precisan un mayor apoyo en su proceso de tratamiento).

Recurso convivencial terapéutico para jóvenes y adolescentes menores de 25 años.

Objetivo general.	Objetivos específicos.	Servicios que presta.
Garantizar un espacio físico de convivencia a la población menor de 25 años con problemas de adicción que carecen de un adecuado soporte familiar o social, que favorezca la estabilización, la adherencia del paciente al tratamiento y su incorporación social.	▪ Llevar a cabo la desintoxicación de aquellas personas que lo precisen en colaboración con los CAD y CCAD. ▪ Realizar un programa personalizado de deshabituación con cada paciente. ▪ Posibilitar la adquisición de hábitos higiénicos y de autocuidados.	▪ Alojamiento. ▪ Manutención. ▪ Programa de intervención educativa y terapéutica que cubre las áreas de: - Convivencia - Terapias grupales y ocupacionales. - Psicoterapias individuales.

Facilitar, mediante actuaciones de carácter socioeducativo la estabilización, la adherencia al tratamiento, y el proceso de incorporación social.	▪ Establecer pautas adecuadas de relación con los miembros del recurso. ▪ Establecer pautas para una ocupación racional del tiempo libre. ▪ Reestructurar las relaciones familiares a través de intervenciones conjuntas del CAD o CCAD de referencia y el recurso. ▪ Promover las iniciativas educativas y formativas para la obtención de títulos oficiales del sistema educativo.	- Grupos de salud, higiene y autocuidados - Talleres y actividades deportivas, lúdicas y culturales. - Talleres y actividades formativas para la obtención de títulos oficiales del sistema educativo.

Comunidades Terapéuticas: CT para pacientes con Patología Dual y CT para pacientes crónicos y/o con deterioro cognitivo.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Proporcionar a la población adicta, que carece del adecuado soporte familiar y social para realizar un tratamiento ambulatorio, una opción de tratamiento en régimen de internado, que contemple la posibilidad de desintoxicación, deshabituación y adquisición de pautas adecuadas de conducta, capaces de facilitar posteriormente su proceso rehabilitador de incorporación social en régimen ambulatorio.	▪ Garantizar un espacio terapéutico residencial que facilite la desintoxicación, la deshabituación y el incremento de la capacidad de autocontrol. ▪ Lograr la adquisición y consolidación de pautas adecuadas de conducta y la prevención de recaídas. ▪ Incorporar hábitos de salud y de autocuidados. ▪ Desarrollar pautas adecuadas de relación. ▪ Favorecer los vínculos y las relaciones familiares satisfactorias. ▪ Fomentar la ocupación racional del tiempo libre. ▪ Posibilitar el proceso de maduración personal. ▪ Incrementar la adherencia al tratamiento.	▪ Alojamiento y manutención. ▪ Programas específicos e individualizados de tratamiento de adicciones. ▪ Desintoxicación. ▪ Dispensación de metadona u otros fármacos. ▪ Intervención psicoterapéutica individual y grupal. ▪ Intervención socioeducativa a través de actividades y talleres formativos y de ocio.

Comunidades Terapéuticas.

Las Comunidades Terapéuticas (C.T.) son un recurso asistencial residencial y especializado en el que las personas drogodependientes son atendidas las 24 horas del día.

1. Comunidad terapéutica para pacientes crónicos o con deterioro cognitivo

Población drogodependiente que tienen largas historias de consumo, múltiples recidivas y tratamientos y carecen de un soporte familiar y/o social adecuado.

2.Comunidad terapéutica para pacientes con Patología Dual

Personas con abuso o dependencia de drogas que presentan además un trastorno mental concomitante.

¿Qué servicios ofrece?

Tratamiento integral que incluye desintoxicación, deshabituación, así como adquisición de pautas adecuadas de conducta capaces de facilitar posteriormente su proceso integración social, atención individual, psicológica y psiquiátrica continuada durante todo el proceso, psicoterapia grupal, intervención socioeducativa a través de actividades y talleres formativos y de ocio…

¿Qué horario tienen?

Recurso residencial con un tiempo de estancia de 6 meses**.**

Forma de acceso

Se accede exclusivamente a través de los centros de atención a las Adicciones (CAD y CCAD), mediante derivación expresa realizada por indicación del equipo terapéutico.

Unidad hospitalaria de Patología Dual (Centro de Patología Dual).

Ofrece un tratamiento integral, con atención individual, psicológica y psiquiátrica continuada durante todo el proceso, psicoterapia grupal, psicoeducación en adicciones y en trastornos mentales y sus tratamientos, entrenamiento en habilidades sociales, afrontamiento y resolución de problemas.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Valoración, desintoxicación, inicio de deshabituación, tratamiento y estabilización de patologías psiquiátricas asociadas a las adicciones en régimen de ingreso hospitalario.	▪ Diagnóstico psicopatológico. ▪ Abordaje terapéutico integral tanto de la adicción como de la psicopatología concomitante. ▪ Mejorar la capacidad de autocontrol. ▪ Promover la adquisición de hábitos saludables y pautas de autocuidados. ▪ Mejorar las habilidades sociales y el desarrollo de pautas adecuadas de relación. ▪ Favorecer la motivación y adaptación de sus actitudes y conductas para la continuidad del tratamiento ambulatorio. ▪ Promover la ocupación racional del tiempo libre.	▪ Tratamiento hospitalario de patologías psiquiátricas y de adicciones (tiempo de estancia mínimo de 3 semanas y máximo de 3 meses). ▪ Intervención psicoterapéutica. ▪ Programas individualizados de atención. ▪ Desintoxicación de sustancias psicoactivas. ▪ Dispensación de metadona y/o de otros fármacos según indicación.

Centro de Día de Patología Dual.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Valoración, tratamiento y estabilización de patologías psiquiátricas asociadas a las adicciones, en régimen de Hospital de Día.	▪ Diagnóstico psicopatológico. ▪ Abordaje terapéutico integral tanto de la adicción como de la psicopatología concomitante. ▪ Mejorar la capacidad de autocontrol. ▪ Promover la adquisición de hábitos saludables y pautas de autocuidados. ▪ Mejorar las habilidades sociales y el desarrollo de pautas adecuadas de relación. ▪ Favorecer la motivación y adaptación de sus actitudes y conductas para la continuidad del tratamiento ambulatorio. ▪ Promover la ocupación racional del tiempo libre.	▪ Tratamiento en régimen de hospital de día de adicciones y de patologías psiquiátricas (tiempo de estancia mínimo de 3 semanas y máximo de 3 meses). ▪ Intervención psicoterapéutica. ▪ Programas individualizados de atención. ▪ Dispensación de metadona y/o de otros fármacos según indicación.

Recursos convivenciales de apoyo al tratamiento y a la reinserción.

. Recursos de apoyo al tratamiento.

. Recursos de apoyo a la reinserción.

. Recursos de autogestión.

. Recursos de apoyo a la reinserción para pacientes con Patología Dual.

. Recursos de apoyo al tratamiento para personas sin hogar.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Proporcionar a la población adicta que carece de un adecuado soporte familiar o social un espacio físico de convivencia que favorezca la estabilización, la adhesión al tratamiento y el proceso de rehabilitación y reinserción social, mediante un adecuado apoyo psico-social en estrecha coordinación con los Centros de Atención a las Adicciones y la adecuación de los diferentes dispositivos convivenciales a las fases o etapas del proceso rehabilitador.	▪ Favorecer el desarrollo de hábitos de convivencia con otras personas y la asunción de las responsabilidades de la vida diaria. ▪ Fomentar la adquisición o mejora de los hábitos de salud, higiene, alimentación y las pautas de autocuidados. ▪ Promover el incremento de la capacidad de autocontrol y la implicación en el proceso terapéutico. ▪ Potenciar la normalización de las relaciones familiares y sociales. ▪ Apoyar las iniciativas educativas y formativo ocupacionales, que resulten adecuadas al momento de su proceso rehabilitador. ▪ Motivar para la incorporación en actividades de ocio y tiempo libre.	▪ Alojamiento. ▪ Manutención. ▪ Programa de intervención socio-educativa que cubre las áreas de: - Convivencia. - Relaciones familiares y sociales. - - Salud, higiene y autocuidados. - Formativo-ocupacional. - De ocio y tiempo libre. - De desarrollo personal. - Apoyo a la integración laboral ▪ Intervenciones psicoterapéuticas en el área psicopatológica para los pacientes con patología dual.

Pisos de Apoyo al Tratamiento (PAT).
Los Pisos de Apoyo al Tratamiento (PAT) son recursos convivenciales temporales, en entorno urbano, para personas que están en tratamiento en los CAD o CCAD. **Perfil de la población atendida** Pacientes que requieren una separación temporal de su entorno familiar y/o social por necesitar una mayor contención y apoyo en las primeras fases del proceso de tratamiento. El Instituto de Adicciones cuenta con plazas en cuatro pisos diferentes y específicos, en función del perfil del paciente o la paciente.

- Personas sin hogar
- Adolescentes y jóvenes menores de 25 años
- Personas que presentan deterioro psicosocial y/o patología dual
- Personas en tratamiento que no se ajustan a las poblaciones anteriores

Forma de acceso

Se accede exclusivamente a través de los centros de atención a las Adicciones (CAD y CCAD), mediante derivación expresa realizada por indicación del equipo terapéutico.

Pisos de Apoyo a la Reinserción.

Los pisos de apoyo a la reinserción ofrecen un espacio convivencial y socioeducativo, en un entorno urbano, que favorece el logro de una vida independiente, autónoma y socialmente normalizada para pacientes mayores de edad de los centros de atención de la red.

Tres tipos de pisos de reinserción:

1) Nivel Básico: Para pacientes de los centros de la Red que se encuentran en etapas avanzadas de tratamiento y que carecen de un núcleo convivencial adecuado.

Tiempo de estancia. 9 meses.

2) De Patología Dual: Para pacientes con patología mental asociada que se encuentran en etapas avanzadas de tratamiento y carecen de un núcleo convivencial adecuado.

Tiempo de estancia 9 meses.

3) De autogestión: Para pacientes que han superado su estancia en los pisos anteriores y con recursos económicos propios. Les permite experimentar la gestión de su vida de forma autónoma e independiente.

Tiempo de estancia: 6 meses

Forma de acceso

Exclusivamente mediante derivación de los centros de atención a las adicciones (CAD y CCAD)

Unidad de Farmacia.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Adquisición, preparación, custodia y distribución de la solución oral de clorhidrato de metadona y aproximar la dispensación al lugar de residencia o trabajo de las personas atendidas, facilitando horarios más amplios que permitan dispensar a personas con dificultades de recogida en los centros de la red en razón del tiempo o del espacio.	▪ Elaborar y suministrar la Solución de Clorhidrato de Metadona a los distintos dispositivos. ▪ Provisión, depósito y transporte a los centros de comprimidos de Clorhidrato de Metadona. ▪ Supervisar la dispensación mediante visitas a los centros.	▪ Dispensación de metadona a pacientes que se encuentran en fases avanzadas de tratamiento (fases 2 y 3). ▪ Petición del fármaco a la Agencia Española del medicamento y recepción del mismo. ▪ Elaboración, almacenamiento y etiquetado de la solución de clorhidrato de metadona.

	▪ Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de estupefacientes. ▪ Custodiar y almacenar estupefacientes (y, si fuese necesario, cualquier medicación que se requiera). ▪ Informar de temas relacionados con los medicamentos a los equipos profesionales que lo necesiten así como a las y los pacientes.	▪ Distribución del fármaco a los diferentes dispositivos de dispensación. ▪ Supervisión de los dispositivos de dispensación y de los diferentes aparatos que intervienen en la dispensación de metadona. ▪ Realización de controles de calidad de metadona. ▪ Formación específica para las y los Técnicas/os de Laboratorio.

Servicio de Orientación Laboral.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Ofrecer a la población adicta atendida en los centros de la red que así lo precise, un servicio de orientación y asesoramiento en temas de formación, capacitación laboral y empleo, con el fin de facilitar una integración laboral estable y de calidad con la colaboración e implicación de los organismos de gestión de empleo y del ámbito empresarial.	▪ Poner a disposición de la población atendida en la Red recursos formativos y de capacitación laboral adecuados a sus necesidades. ▪ Ofrecer una orientación y un seguimiento individualizado del proceso de integración laboral. ▪ Incrementar la accesibilidad al empleo por cuenta ajena y al autoempleo. ▪ Facilitar la integración laboral a personas con muy baja empleabilidad. ▪ Impulsar la creación de convenios con otras Áreas Municipales y con otras Instituciones, en orden a facilitar los procesos de integración socio-laboral de las personas en tratamiento, prestando especial atención al empleo protegido. ▪ Implementar, de modo transversal, medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género, orientadas a facilitar el proceso de integración sociolaboral de las mujeres atendidas en la red.	▪ Servicio integral de: orientación, asesoría, formación, intermediación y acompañamiento en materia de integración laboral. ▪ Realiza itinerarios orientados hacia: - La formación. - El empleo por cuenta ajena. - El autoempleo. - La mejora y mantenimiento del empleo. - El empleo protegido. ▪ Presta especial atención a las personas y colectivos con mayores dificultades o en mayor riesgo de exclusión.

Servicio de Orientación Laboral para adolescentes y jóvenes.

Objetivo general.	Objetivos específicos.	Servicios que presta.
Ofrecer a adolescentes y jóvenes que presenten conductas de riesgo o que presentan alguna dimensión de la conducta adictiva, atendidos en los recursos de la red y que así lo precisen, un servicio de orientación y asesoramiento en temas de formación, capacitación laboral y empleo, con el fin de facilitar una integración laboral estable y de calidad, con la colaboración e implicación de los organismos de gestión de empleo y del sector empresarial.	▪ Poner a disposición de adolescentes y jóvenes recursos formativos y de capacitación laboral adecuados a sus necesidades. ▪ Ofrecer una orientación y un seguimiento individualizado del proceso de integración laboral. ▪ Incrementar la accesibilidad al empleo por cuenta ajena y al autoempleo. ▪ Facilitar la integración laboral a adolescentes y jóvenes con baja empleabilidad. ▪ Impulsar la creación de convenios con otras Áreas Municipales y con otras Instituciones, en orden a facilitar los procesos de integración socio-laboral de adolescentes y jóvenes, prestando especial atención al empleo protegido. ▪ Implementar, de modo transversal, medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género, orientadas a facilitar el proceso de integración sociolaboral de las mujeres adolescentes y jóvenes atendidas en la red.	▪ Servicio integral de: orientación, asesoría, formación, intermediación y acompañamiento en materia de integración laboral. ▪ Realiza itinerarios orientados hacia: - La formación. - El empleo por cuenta ajena. - El autoempleo. - La mejora y mantenimiento del empleo. - El empleo protegido. ▪ Presta especial atención a las personas y colectivos con mayores dificultades o en mayor riesgo de exclusión.

Talleres prelaborales de capacitación.

Objetivo general.	Objetivos específicos.	Servicios que presta.
Facilitar a las personas en tratamiento que lo precisen, una formación y capacitación profesional que mejore sus niveles de empleabilidad y propicie una adecuada inserción laboral.	▪ Proporcionar a los usuarios/as de la red que lo precisen una formación útil para su inserción laboral. ▪ Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas en la red.	▪ Formación en carpintería y ebanistería. ▪ Formación en peluquería. ▪ Formación en costura.

	▪ Favorecer la adherencia al tratamiento y la evolución positiva en el mismo, a través del logro de una imagen más positiva y activa de las personas en tratamiento y una mayor implicación en su proceso rehabilitador.	

Talleres prelaborales de capacitación para adolescentes y jóvenes.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Facilitar a adolescentes y jóvenes que lo precisen una formación y capacitación profesional que mejore sus niveles de empleabilidad y propicie una adecuada inserción laboral.	▪ Proporcionar a los usuarios/as de la red que lo precisen una formación útil para su inserción laboral. ▪ Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas en la red. ▪ Favorecer la adherencia al tratamiento y la evolución positiva en el mismo, a través del logro de una imagen más positiva y activa de las personas en tratamiento y una mayor implicación en su proceso rehabilitador.	▪ Formación en carpintería y ebanistería. ▪ Formación en peluquería. ▪ Formación en costura.

Servicio de Atención a Jueces e Información al Detenido (SAJIAD).

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Favorecer la plena integración social de las personas con adicciones con problemas judiciales. Favorecer la plena integración social de jóvenes en riesgo o con problemas de adicción y con problemas judiciales.	▪ Informar y orientar a drogodependientes implicados en diligencias judiciales por la comisión de delitos relacionados con su dependencia a las drogas. ▪ Informar y asesorar a las familias de drogodependientes detenidos. ▪ Asesorar técnicamente, de forma no vinculante, a los jueces sobre las circunstancias socio-personales de estas personas.	▪ Orientación y asesoramiento a los drogodependientes con diligencias judiciales, y a sus familias. ▪ Asesoría en materia de adicciones a jueces, fiscales y forenses. ▪ Emisión de informes técnicos y periciales.

	▪ Facilitar el acceso de estas personas a los centros de tratamiento mediante la coordinación con los mismos. ▪ Ofrecer canales de mediación entre la Administración de Justicia y la Red de Atención a las Adicciones. ▪ Facilitar la elaboración y dispensación de metadona a las personas detenidas, en libertad condicional o provisional, o en remisión de pena, que así lo precisen. ▪ Agilizar la captación y derivación de jóvenes de entre 18 y 24 años detenidos en los calabozos de los Juzgados de Guardia de Madrid.	▪ Coordinación y conexión con recursos asistenciales generales y/o servicios específicos en drogodependencias (incluye capacidad de control analítico y de mantenimiento de programas de sustitutivos opiáceos, durante la estancia en dependencias judiciales). ▪ Colaboración en el control de la abstinencia al consumo de drogas de las personas que se encuentran en libertad provisional, libertad condicional o en situación de remisión condicional de pena.

Programa de Apoyo al movimiento asociativo.

Objetivo general.	**Objetivos específicos.**	**Servicios que presta.**
Promocionar y fomentar la colaboración de la iniciativa social en acciones de interés para el desarrollo de la política sociosanitaria del Instituto de Adiciones de la Ciudad de Madrid.	▪ Favorecer la participación de la iniciativa social mediante la convocatoria anual de subvenciones para proyectos que basados en la evidencia y con especial interés socio-sanitario, estén destinados a favorecer la prevención, el tratamiento y la integración y normalización social de las personas con problemas de adicciones. ▪ Favorecer la coordinación de los dispositivos de la red municipal con las entidades que desarrollan proyectos en el ámbito de las adicciones, potenciando el efecto de las actuaciones en red.	▪ Subvención de Proyectos de intervención en materia de adicciones. ▪ Difusión de los proyectos y actividades, para promover su utilización. ▪ Seguimiento del desarrollo de los programas subvencionados. ▪ Apoyo en las tareas de coordinación entre entidades subvencionadas y otras instituciones que operan en el ámbito de las adicciones.

2.- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD.

En octubre de 2.012, el Instituto de Adicciones publicó el **Protocolo de intervención desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Drogodependencias del Instituto de Adicciones.**

Los **objetivos del protocolo** son:

1.- Definir, enriquecer, homogeneizar y ajustar las aportaciones que se realizan desde el área social al proceso de atención integral a las drogodependencias contenido en el Plan de Adicciones para la Ciudad de Madrid 2011-2016, como forma de ajustar las intervenciones del equipo interdisciplinar a las necesidades de los pacientes, coordinando las mismas y evitando duplicidades, solapamientos o vacíos en la intervención.

2.- Facilitar la tarea de los trabajadores sociales, aportando diferentes metodologías y estrategias de intervención, tanto individuales como familiares, grupales y comunitarias y recopilando experiencias de buenas prácticas en la intervención social en adicciones.

Este documento ubica las funciones del trabajador social dentro del **proceso de atención integral** descrito en el Plan de Adicciones.

2.1.- EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN EL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL.

1.- ATENCIÓN A LA DEMANDA INICIAL.

La atención a la demanda se lleva a cabo mediante dos actuaciones: **la recepción y la acogida.**

Recepción.	Es la primera actuación que realiza el personal del CAD para atender una demanda nueva o un reingreso. Se suele realizar por el personal administrativo e incluye la escucha de la demanda, la toma de datos iniciales y la asignación de una primera cita con un técnico.
Acogida.	Es la primera entrevista con un técnico, ya sea por primera vez o como reingreso después de una atención previa. Los objetivos son la escucha activa de la demanda, la recogida de la información mínima imprescindible, la comprobación de prioridades en la atención (embarazo, riesgo para los hijos, consumos de alto riesgo, trastornos psiquiátricos ...), informar y orientar sobre las actuaciones posibles, la generación de empatía y vínculos terapéuticos, la motivación al paciente o la asignación de citas con otros profesionales. La **entrevista motivacional breve** es una herramienta de gran utilidad en estas primeras fases de la intervención, ayudando al paciente a salir de su ambivalencia inicial y apoyando su deseo de cambio. Se cumplimentan: RAD Sanitario, RAD Social, Historia de consumo, Sustancia principal, Vía y motivo de acceso.

2.- VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR.

La valoración de todos los pacientes se realiza desde las áreas sanitaria, psicológica, social y ocupacional, realizándose su evaluación en las 7 dimensiones señaladas en el modelo de atención integral: salud y auto-cuidados, psicopatología, consumo, familiar, socio-relacional, formativo-laboral y ocio.

El estudio y diagnóstico social incluye formación relativa al paciente y su entorno (medio familiar y social). Se realiza una síntesis de sus características, necesidades sociales y dificultades, fortalezas ... y se complementa con información sobre las drogas utilizadas, la vivencia del problema por el usuario y su familia o la motivación para la intervención. El instrumento que se utiliza es la **historia social.** Dentro del CAD se utiliza además el **Sistema de Evaluación Multidimensional o Sistema de evaluación objetiva de resultados del tratamiento** en el modelo de atención integral.

Esta recogida de información se complementa con una **primera hipótesis de trabajo o propuesta de intervención social**, que incluye la utilización de recursos de la red y de recursos externos.

Una variable especialmente importante es la inclusión del paciente en alguno de los colectivos con necesidades especiales descritos en el modelo.

3.- EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL Y DISEÑO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN (PPI).

Las diferentes perspectivas profesionales obtenidas deben concluir en una **evaluación multidimensional** en función de las siete dimensiones o ejes ya señalados. A partir de esta evaluación el equipo diseña el **programa personalizado de intervención (PPI).**

El PPI debe incluir:

- Los objetivos que se pretenden conseguir con la intervención.
- Las actividades a desarrollar para la consecución de dichos objetivos.
- Los recursos de apoyo que se consideren necesarios.

Los objetivos son compartidos por los profesionales, pero las distintas disciplinas aportan estrategias, técnicas y contenidos de intervención diferentes y complementarios. El trabajador social asesora acerca de la situación social del paciente, sus necesidades sociales y los recursos de apoyo más adecuados.

El PPI debe ser consensuado con el paciente y, a veces también, con la familia, como paso previo a su definición y concreción. La devolución de los resultados de la valoración multidimensional permite:

- Trasladar al paciente –a veces, a la familia- una información objetiva, clara y precisa de los problemas y fortalezas encontrados para tomar conciencia del problema y de las posibles soluciones.
- Constatar el grado de conocimiento y conciencia del problema.
- Argumentar las razones del plan de intervención, sus ventajas y dificultades, el papel que puede jugar la familia.
- Explicar los contenidos y acciones del PPI, la incorporación a grupos, las citas, la administración de fármacos ...
- Ajustar los objetivos del PPI a la situación particular del paciente para logra su máxima implicación.
- Adecuar las expectativas iniciales del paciente, reajustando las que sea inadecuadas y reconvirtiendo las que son poco realistas.

4.- DESARROLLO DEL PPI.

Una vez diseñado y consensuado el PPI se inicia su desarrollo que incluye, además, su seguimiento y evaluación continua, de forma que se puedan introducir las modificaciones necesarias en función de la evolución del paciente. La intervención del trabajador social dependerá de la mayor o menor presencia de factores de riesgo de exclusión social: a mayor presencia de riesgo de exclusión social, la intensidad de la intervención del trabajador social deberá ser mayor.

El TS interviene en la consecución de todos los objetivos fijados en los 7 ejes recogidos de la evaluación.

EJE 1: Salud / autocuidados.

OBJETIVO GENERAL. Reducir y controlar los riesgos y daños asociados y/o producidos por el consumo de drogas. Conseguir hábitos saludables.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Conseguir y mantener el estado nutricional adecuado. 2.- Conseguir y mantener hábitos de higiene saludables. 3.- Adquirir y mantener una sexualidad saludable. 4.- Conseguir y mantener la adherencia al tratamiento. 5.- Prevenir y controlar las patologías asociadas e/o inducidas por el consumo de drogas para mejorar la calidad de vida.	. Entrevistas semiestructuradas de información y asesoramiento. . Entrevistas motivacionales individuales y familiares. . Entrevistas de seguimiento presencial y/o telefónico pautadas. . Informes sociales. . Recursos de apoyo al tratamiento y la reinserción que resulten adecuados a la situación del paciente. . Grupos de acogida / inicio.

EJE 2: Psicopatología.

OBJETIVO GENERAL. Lograr la mayor estabilidad psíquica del paciente.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Restablecer el contacto con la realidad, alterado por trastornos del pensamiento y/o la percepción. 2.- Reducir el nivel de ansiedad patológico. 3.- Estabilizar el estado de ánimo. 4.- Incrementar la capacidad de autocontrol del sujeto y minimizar el riesgo de violencia. 5.- Minimizar el riesgo de suicidio.	. Entrevistas semiestructuradas de información y asesoramiento. . Entrevistas motivacionales individuales y familiares. . Entrevistas de seguimiento presencial y/o telefónico pautadas. . Trabajo en grupo de pacientes. . Visita a recursos y tejido asociativo de la zona.

6.- Optimizar las capacidades cognitivas del paciente para que sea funcional.	

EJE 3: Consumo.

OBJETIVO GENERAL. Lograr la abstinencia, la máxima reducción del consumo o el consumo de menor riesgo.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Conocer e identificar los efectos y riesgos de las drogas que consume. 2.- Abandonar o reducir el consumo de las drogas para las que solicita tratamiento. 3.- Evitar o reducir el consumo de drogas que no han generado la demanda. 4.- Evitar o reducir los daños y riesgos asociados al consumo y a la vía de consumo. 5.- Evitar, disminuir o distanciar las recaídas y reducir su impacto.	. Entrevistas semiestructuradas, motivacionales y de tratamiento. . Grupos de educación para la salud. . Grupos de prevención de recaídas.

EJE 4: Familiar.

OBJETIVO GENERAL. Conseguir y mantener unas relaciones familiares adecuadas y satisfactorias para el paciente.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Tomar conciencia de su posición en la estructura y dinámica familiar para mejorar su funcionalidad. 2.- Identificar la función del consumo y generar alternativas. 3.- Adecuar el grado de implicación de la familia en el tratamiento. 4.- Afrontar las diferentes situaciones de crisis de forma eficaz, minimizando las repercusiones de la historia familiar.	. Genograma. , Entrevistas orientativas y motivacionales individuales, familiares y/o por subsistemas. . Trabajo en grupos de familiares. . Escuela de familias. . Empleo de técnicas activas. . Visitas al domicilio para comprender el contexto de la familia y su capacidad de adaptación. . Coordinación con recursos: Servicio de Apoyo a la Prevención, Centros SS.SS., CAF, CAI, SAVG, ...

EJE 5: Socio-relacional.

OBJETIVO GENERAL. Conseguir y mantener unas relaciones sociales saludables.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Establecer y mantener vínculos sociales fuera del ámbito del consumo. 2.- Adquirir, potenciar y mejorar las habilidades sociales. 3.-Adquirir y mantener una actitud social autónoma y responsable. 4.- Conocer y utilizar adecuadamente los recursos sociales normalizados. 5.- Lograr la autonomía en relación al núcleo de convivencia.	. Entrevistas motivacionales. . Entrevistas de seguimiento. . Ecomapa. . Visitas a recursos comunitarios. . Dinámicas grupales, role-playing, modelado. . SAJIAD, servicios de orientación jurídica, SS.SS. penitenciarios. . Servicios de voluntariado y ONGs. . SS.SS., centros culturales, de salud, educativos, deportivos ... . Entrevistas individuales y familiares. . Red de recursos para la atención a PSH. . Prestaciones sociales (RMI, RAI, subsidios ...).

EJE 6: Formativo laboral.

OBJETIVO GENERAL. Conseguir y mantener una formación y/o trabajo adecuado, satisfactorio y estable.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Fomentar la motivación e implicación del paciente en su proceso de formación y empleo. 2.- Ajustar las expectativas formativo-laborales del usuario en función de su perfil profesional y de la situación del mercado laboral. 3.- Adquirir herramientas para conseguir el mayor grado posible de capacitación laboral, en orden a incrementar la empleabilidad. 4.- Conseguir que su situación laboral sea adecuada a su situación vital.	. Entrevistas individuales (informativas, motivacionales, de seguimiento, etc). . Intervención grupal (grupo técnico de empleo), itinerario personalizado formativo-laboral. . Servicio de Orientación Laboral (SOL). . Otros recursos del sector y Servicios Públicos de Empleo. . Informes de derivación.

EJE 7: Ocio.

OBJETIVO GENERAL. Lograr la organización productiva del tiempo libre y el disfrute de un ocio saludable.	
Objetivos específicos.	**Instrumentos de apoyo.**
1.- Lograr el mayor grado posible de motivación para el ocio y el desarrollo de intereses para un ocio saludable. 2.- Optimizar las competencias para organizar el tiempo y las actividades. 3.- Lograr el adecuado desarrollo de actividades de ocio saludable, tanto solitario como compartido y la disminución de actividades de ocio de riesgo.	. Entrevistas individuales (informativas, motivacionales, de seguimiento, etc). . Entrevistas con familia. . Intervención grupal (grupo técnico de ocio). . Terapeuta ocupacional del equipo. . Red de apoyo social. . Voluntariado. . Asociaciones y ONGs orientadas al ocio saludable. . Centros y recursos de ocio (deportivos, culturales, recreativos, etc). . Prestaciones económicas, ayudas de transporte, tarjeta de polideportivos, etc. . Informes de derivación.

Intervención individual.

Para lograr este fin la intervención puede centrarse exclusivamente en el propio paciente –mediante intervenciones individuales o grupales- o, si el paciente lo admite, también puede incluir a la familia. En el caso de la intervención individual la técnica fundamental de intervención es la **entrevista** (de recogida de datos, informativa, motivacional, de asesoramiento, de seguimiento ...).

Igualmente, el TS participa en diferentes tipos de grupos, ya sea como coordinador principal o como colaborador de otro profesional del equipo: grupos de acogida/inicio, grupos de educación para la salud, grupos de prevención de recaídas o grupo técnico de ocio.

Intervención con la familia.

Es una actuación prioritaria, aunque no es posible plantearla con todos los pacientes, ya sea por su expreso deseo o por dificultades o falta de motivación por parte de la familia. La entrevista es la técnica fundamental, ya sea con familias que tienen a uno de sus miembros en tratamiento en el CAD o con familias "solas" –consultan o solicitan apoyo y orientación para un familiar afectado que no acude a tratamiento-.

Con las familias se trabaja tanto a nivel individual –con cada familia- como a nivel grupal, existiendo diferentes tipos de grupos adaptados a las necesidades que se plantean en las diferentes etapas del tratamiento o en función de los objetivos que se pretenden conseguir.

5.- COORDINACIÓN.

En los CAD los trabajadores sociales llevan a cabo dos tipos de coordinaciones:

- **Internas:** reuniones con el resto de los miembros del equipo para diseñar e implementar el PPI de los casos nuevos, así como para realizar un seguimiento y evaluación continuada de los pacientes que están en tratamiento.
- **Externas:** con técnicos de los recursos que son necesarios en el proceso de atención, ya de la propia red de adicciones –SOL, SAJIAD, ISTMO, pisos de apoyo al tratamiento y a la reinserción …-, o de recursos comunitarios: salud mental, servicios sociales, vivienda, empleo, educación …

6.- EVALUACIÓN.

El sistema de evaluación objetiva de resultados de tratamiento incluye una serie de indicadores que permiten medir objetivamente los cambios en las diferentes dimensiones de la intervención. Esta evaluación facilita un seguimiento continuo del paciente y permite comparar la situación actual con la situación de partida en cada una de las dimensiones en función de los objetivos marcados en el PPI.

2.2.- INTERVENCIONES CON COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES.

Entre las personas susceptibles de ser atendidas en la red del Instituto de Adicciones existen colectivos o subgrupos de población que plantean unas especiales características y necesidades. El Plan de Adicciones contempla un esfuerzo de adaptación y asignación de recursos a aquellos colectivos que presentan especiales dificultades o necesidades: adolescentes y jóvenes, mujeres en especial situación de vulnerabilidad, pacientes con bajo potencial de cabio (requieren tratamientos prolongados), pacientes con patología dual, drogodependientes sin hogar …

Entre las actuaciones del TS respecto de estos colectivos, podemos señalar las siguientes:

- Motivación y apoyo para el mantenimiento o incorporación a actividades de carácter educativo, cultural, de capacitación laboral y/o de inserción laboral.
- Promoción de hábitos y estilos de vida saludables, organización del ocio y de las relaciones sociales.
- Apoyo en el restablecimiento, mantenimiento y/o mejora de los vínculos socio-familiares.
- Acompañamiento social durante todo el proceso y trabajo en red con otros profesionales y dispositivos, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género y de multiculturalidad.
- Orientación para la adecuada utilización de los recursos que precise (sociales, judiciales, formativo-laborales, de ocio, etc).
- Motivación y apoyo para la realización de gestiones como la obtención y/o recuperación de su documentación básica (DNI, Tarjeta sanitaria …), tramitación de prestaciones o recursos.
- Motivación y apoyo, si procede, para acciones de atención básica de proximidad, educación de calle y acompañamientos por parte de entidades y voluntariado.

En el caso de pacientes con conflictos legales o judiciales se realizan intervenciones como:

- Indagación sobre la situación judicial del paciente, orientación legal básica ...
- Derivación a recursos de información y asesoramiento legales –Oficinas de Información Judicial, SAJIAD (Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al detenido drogodependiente)-.
- Elaboración de informes de seguimiento de pacientes con medidas judiciales que sean requeridos por los jueces.
- Emisión de informes a petición de los ETMF, los CAF y los CAI en procedimientos tales como protección de menores, litigio o situaciones de violencia familiar, procesos de incapacitación, tutela y curatela.
- Asesoramiento al equipo técnico del CAD.

2.3.- INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD.

La principal tarea profesional del TS va orientada a la atención integral del paciente y al logro del mayor grado posible de integración familiar y social del mismo. Entre los problemas que suelen aparecer relacionados con las adicciones es frecuente observar una ausencia o debilidad de los vínculos con el entorno, una falta de sentimiento de pertenencia o una percepción de sí mismo y de los propios problemas como algo ajeno a la realidad familiar y social. Este tipo de sentimientos y percepciones, unidos al consumo de sustancias, contribuyen a retroalimentar de forma negativa la imagen de la realidad y de sí mismo, incrementando el aislamiento social y la exclusión.

La (re)construcción del vínculo social implica incluir la mirada en la comunidad, para romper el círculo negativo de consumo y exclusión y para potenciar fortalezas como la participación, la integración y la responsabilidad social. Junto al trabajo realizado con pacientes y familias se promueve el trabajo con la propia comunidad y con sus instituciones para potenciar su implicación y responsabilidad en el tema de las adicciones y se facilite la aceptación y la integración social de las personas afectadas.

Algunas de las actuaciones de los TS de los CAD con esta orientación hacia la fortaleza de la comunidad son:

- Atención a grupos de jóvenes y docentes procedentes de diferentes recursos educativos para difundir la labor de los CAD y sensibilizar respecto a los riesgos asociados al consumo de sustancias.
- Participación en las CAF y ETMF y otras plataformas conjuntas en las que, más allá de la reflexión y toma de decisiones sobre casos concretos, se establecen canales de coordinación y acción conjunta entre diversos servicios e instituciones.
- Promoción y planificación de actuaciones grupales junto con otros recursos del distrito: CMS, Agentes de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales.
- Trabajo en red con el tejido asociativo de los distritos.
- Valoración conjunta de los casos que requieran un abordaje comunitario.

2.4.- INTERVENCIÓN GRUPAL EN LOS CAD.

En el anexo del Protocolo de Intervención desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Adicciones se recogen diversos ejemplos de grupos en funcionamiento en los CAD.

GRUPO DE ACOGIDA PARA PACIENTES Y FAMILIARES.

. Perfil participantes.

Drogodependientes que han hecho demanda de tratamiento en el CAD y familiares que deseen acompañarles.

. Objetivos.

. Facilitar la adherencia al tratamiento y minimizar los abandonos.

. Proporcionar una respuesta ágil a las demandas recibidas en el CAD.

. Lograr que los nuevos pacientes y sus familiares conozcan el proceso de atención en el CAD y que lo entiendan como un proceso integral.

. Reconvertir las demandas no ajustadas a la realidad.

. Contenidos.

. El CAD como centro de referencia en el proceso de tratamiento (papel del profesional de referencia y del resto del equipo técnico, horarios, etc.)

. El proceso de atención (valoración interdisciplinar, formas de desintoxicación, recurso de apoyo al tratamiento y a la reinserción residenciales y no residenciales, etc.).

. Voluntariedad del tratamiento.

. Confidencialidad en la atención, informes, etc.

GRUPO TERAPÉUTICO PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE ALCOHOL.

. Perfil participantes.

Pacientes con abuso o dependencia del alcohol, en situación de abstinencia, que han sido derivados al grupo por los técnicos del equipo.

No padecer patología psiquiátrica que interfiera en el funcionamiento del grupo.

. Objetivos.

. Lograr el mantenimiento de la abstinencia al consumo de alcohol.

. Lograr que el paciente perciba como un problema el consumo de alcohol.

. Modificar hábitos y actitudes disfuncionales.

. Mejorar la comunicación y expresión de sentimientos.

. Prevenir y/o detectar precozmente las recaídas.

. Contenidos.

. Conceptos relacionados con el alcohol.

. Efectos del consumo de alcohol.

. Alteraciones orgánicas relacionadas con el uso/abuso del alcohol.

. Consecuencias personales, familiares, sociales, laborales y de salud

. Creencias erróneas acerca de los beneficios de su uso.

. Factores de riesgo y de protección frente al consumo de alcohol.

. Estrategias de afrontamiento de recaídas.

GRUPO TERAPÉUTICO PARA PACIENTES CON PROBLEMAS CON LA COCAÍNA, THC Y/O ALCOHOL.

. Perfil participantes.

Pacientes con abuso o dependencia de la cocaína, que estén estabilizados, no tengan un consumo activo (abstinencia mínima de 15 a 20 días) y tengan una motivación suficiente para el trabajo grupal.

Pacientes con dependencia del THC y/o alcohol, que reúnan características similares en cuanto a edad y estilo de vida.

. Objetivos.

. Lograr y consolidar la abstinencia.

. Lograr que el paciente identifique las situaciones de riesgo de consumo.

. Lograr que el paciente sea capaz de generar alternativas saludables.

. Incrementar la motivación para el tratamiento y la adhesión al mismo.

. Proporcionar y/o consolidar en el paciente estrategias adecuadas de afrontamiento ante las situaciones de riesgo. (Prevenir recaídas)

. Contenidos.

. Conceptos relacionados con la cocaína y otras drogas.

. Efectos del consumo de cocaína y de otras drogas.

. Consecuencias personales, familiares, sociales, laborales y de salud.

. Factores de riesgo y de protección frente al consumo.

. Estrategias de afrontamiento de recaídas.

GRUPO TERAPÉUTICO PARA PACIENTES SIN HOGAR.

. Perfil participantes.

Pacientes en situación de calle o en albergues.

. Objetivos.

. Lograr que los participantes se integren en la red social normalizada.

. Lograr que los pacientes adquieran conocimientos básicos de educación para la salud.

. Mejorar la integración social de los pacientes y la utilización adecuada de los recursos.

. Posibilitar el tratamiento ambulatorio (desde el CAD) de su problemática de adicción.

. Contenidos.

. Conceptos básicos sobre drogodependencias

. Conceptos de educación para la salud.

. Recursos sociales, sanitarios, etc. a utilizar por los pacientes.

GRUPO TERAPÉUTICO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES.

. Perfil participantes.

Pacientes que, a criterio del equipo, se puedan beneficiar de un trabajo en habilidades sociales.

. Objetivos.

. Mejorar las competencias sociales de los pacientes.

. Lograr que los pacientes tengan un comportamiento asertivo en situaciones cotidianas.

. Lograr una disminución de los comportamientos agresivos y pasivos.

. Mejorar la comunicación y expresión de sentimientos.

. Contenidos.

. Conceptos sobre competencia social.

. Conceptos sobre asertividad, comportamiento asertivo frente a comportamiento pasivo y agresivo.

. Niveles de comunicación, ajuste de la comunicación al interlocutor y a la situación.

GRUPO TERAPÉUTICO DE MUJERES DROGODEPENDIENTES.

. Perfil participantes.

Mujeres en tratamiento, independiente de la sustancia de abuso o dependencia, que estén estabilizadas y que no tengan un consumo activo (abstinencia mínima de 1 mes)

. Objetivos.

. Consolidar la abstinencia.

. Mejorar la autoestima y la aceptación como mujeres.

. Incrementar la responsabilidad personal acerca de su propia vida.

. Lograr el mayor grado posible de integración social.

. Contenidos.

. Autoestima, autoimagen.

. Culpa, codependencia.

. Aislamiento e integración social.

GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES DE PACIENTES (niveles 1 y 2).

. Perfil participantes.

Familiares de pacientes en tratamiento en el CAD, que hayan sido derivados al grupo por el equipo técnico y que cuenten con el consentimiento del paciente para participar en el tratamiento.

. Objetivos.

. Mejorar las relaciones familiares, la dinámica y funcionalidad familiar.

. Incrementar la competencia e implicación de la familia para apoyar el tratamiento del paciente consumidor.

Facilitar la integración familiar y social del paciente.

. Contenidos.

. Aspectos básicos de drogas y drogodependencias

. Normas y límites.

. Negociación y comunicación.

. Situaciones de crisis familiar (conflictos, cambios vitales, recaídas, etc.).

. Características del proceso terapéutico.

. Cuidados del familiar afectado: Relaciones sociales, organización del tiempo, asunción de responsabilidades, actividades reforzantes, etc.

. Manejo de emociones.

GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.

. Perfil participantes.

Familiares de pacientes en tratamiento en el CAD, menores de 25 años.

. Objetivos.

. Mejorar las relaciones familiares, la dinámica y funcionalidad familiar.

. Incrementar la competencia e implicación de la familia para apoyar el tratamiento del paciente consumidor.

. Disminuir los niveles de angustia y culpa que suelen soportar.

. Facilitar la integración familiar y social del paciente.

. Contenidos.

. Aspectos básicos de drogas y drogodependencias.

. Características de la adolescencia y primera juventud.

. Normas y límites.

. Negociación y comunicación.

. Hábitos y responsabilidades del adolescente/joven.

. Situaciones de crisis familiar (conflictos, cambios vitales, recaídas, etc.).

. Características del proceso terapéutico.

. Manejo específico del adolescente/joven consumidor.

. Manejo de emociones.

Bibliografía

. Protocolo de intervención desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Adicciones de Madrid Salud.
https://pnsd.sanidad.gob.es/ca/pnsd/buenasPracticas/protocolos/pdf/ProtocoloIntervSocial.pdf

. Anexos al Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid, 2.017-2.021.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Adicciones/PlandeAdicciones/ficheros/PlanAdicciones2017-2021_Anexos.pdf

. Documentación página web. Instituto de Adicciones.